

## Hemorragia digestiva alta · abordagem

HDA = sangramento proximal ao Treitz (hematêmese, melena, tipicamente). Estabilize volume, inicie IBP e defina timing da EDA conforme gravidade e estigmas de risco.

### Úlcera vs variz

#### Dica - Úlcera vs variz

Sempre pergunte hepatopatia/álcool/hipertensão portal. Varizes: terlipressina/octreotida + ATB profilático + EDA. Úlcera: IBP em infusão/alta dose + EDA com terapia se Forrest de risco.

*Fluxo: vias aéreas/volume !' IBP ± vasoativo na variz !' EDA diagnóstica e terapêutica.*

### HDA na emergência

Ressuscitar -> IBP -> endoscopia

ABC + volume

2 acessos / sangue

IBP +/- terlipressina

úlcera vs variz

EDA precoce

diagnóstico + terapia

### Passos iniciais

- Via aérea se hematêmese maciça / rebaixamento; O<sub>2</sub> e monitorização
- Volume e hemoglobina alvo prudente (evitar transfusão liberal no estável)
- Corrigir coagulopatia conforme contexto; suspender anticoagulante com critério
- EDA preferencialmente nas primeiras 24 h; mais cedo se instável após ressuscitação

### Forrest (ideia de risco)

#### Classificação | Risco / ideia

Ia / Ib | Sangramento ativo — terapia endoscópica

Ila | Vaso visível — alto risco, terapia

Ilb | Coágulo aderente — avaliar remoção/terapia

Ilc / III | Manchas / base limpa — baixo risco

### Armadilha de prova

#### Atenção - Armadilha de prova

Melena não é 'só HDB'. Sangue digerido de HDA é causa clássica. Hematêmese/HNIA alta + instabilidade !' trate como HDA até prova em contrário.

### Para a prova — escalas e macetes

#### Lembre - Para a prova — escalas e macetes

HDA: ressuscitar, IBP, estratificar Forrest na EDA — classificação que define terapia endoscópica e risco de ressangramento.

Forrest I e IIa/IIb = alto risco !' terapia endoscópica + IBP. IIc/III = baixo risco.

## Forrest - HDA ulcerosa

Classificação endoscópica

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ia - sangramento jato arterial   | Alto  |
| Ib - sangramento babando         | Alto  |
| IIa - vaso visível não sangrante | Alto  |
| IIb - coágulo aderido            | Alto* |
| IIc - mancha de hematina         | Baixo |
| III - base limpa / fibrina       | Baixo |

Ia jato | Ib babando | IIa vaso | IIb coágulo | IIc hematina | III base limpa

## Conduta inicial

### Lembre - Conduta inicial

ABC, 2 acessos, tipagem, reposição criteriosa, IBP EV precoce. Suspeita de variz: vasoativo (terlipressina/octreotida) + ATB + EDA. Úlcera: EDA com terapia se Forrest de risco.

### Fluxo HDA (prova)

- Ressuscitar e proteger via aérea se hematêmese maciça
- IBP EV; vasoativo + ATB se provável variz
- EDA precoce para diagnóstico e terapia (Forrest)

### Forrest e conduta

- Ia/Ib/IIa: terapia endoscópica (injeção, clip, termocoagulação) + IBP alto
- IIb: remover/inspecionar coágulo quando seguro; tratar se lesão de risco sob ele
- IIc/III: IBP; alta precoce possível se estável e sem outros riscos
- Falha endoscópica / instabilidade refratária: embolização ou cirurgia

## Variz vs úlcera

### Dica - Variz vs úlcera

Hepatopatia, ascite, estigmas de hipertensão portal !' trate como variz até a EDA. Rockall/Glasgow-Blatchford ajudam risco, mas Forrest manda na úlcera.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1